Pedido de datos para medir el abandono del tratamiento

LUUMA · Medición del abandono · definición 0.10 · versión 2.2 (borrador para revisión)

Para qué es y qué recibe la clínica

Con la misma definición en todas las clínicas medimos el abandono por ciclo: cada punción abre un ciclo que termina en un bebé, sigue (una nueva punción u ovodonación) o termina en abandono, cuando pasan 12 meses sin ninguna punción, transferencia ni ovodonación.

A cambio, la clínica recibe su propio informe (HTML y PDF): «de cada 100 punciones, cuántas terminan en un bebé, cuántas siguen y cuántas en abandono», en qué momento se pierden las pacientes, cómo varía por edad y la calidad de sus datos, con una calculadora editable de ingresos en riesgo. Si tiene varias sedes, el informe las compara entre sí; nunca se la compara con otra organización. La app lo genera en la computadora de la clínica.

Qué reportes pedir: tal como salen del sistema

No hace falta procesar nada: ni calcular, ni agrupar, ni recodificar. Exporten cada reporte completo, como sale (Excel o CSV, con los nombres de columna que tenga). Período: todas las punciones desde que el registro es confiable (idealmente 3 años o más) y todo lo que pasó después.

Reporte	Nivel	Qué tiene que traer
Punciones	Imprescindible	Paciente (el mismo número en todos los reportes), fecha y tipo de punción (propia, donante, preservación de óvulos, cancelada), **edad a la punción** (o fecha de nacimiento) y, si la clínica tiene más de una sede, la **sede**. Si los trae: médico, cobertura, ciclos previos.
Transferencias	Imprescindible	Paciente, fecha, sede (si hay más de una) y el desenlace (negativo, pérdida, nacido vivo, en curso), no solo la β-hCG; acá o en su propio reporte. Si los trae: fecha de la pérdida, origen del embrión (propio o donado), de qué punción salieron los embriones (número o fecha de la punción), número de transferencia.
Fecha de corte	Imprescindible	Hasta qué día está completo el registro. Puede ser el día en que exportan. Además: desde qué fecha tiene registro completo cada sede (hace falta para saber si una punción es la primera o no).
Ovodonación	Imprescindible si hay programa de ovodonación	Paciente y fecha del ciclo. Sin este reporte, la paciente que pasa a ovodonación figura como abandono y la tasa sale más alta de lo real.

Embriología por punción	Muy recomendable	Paciente y fecha (o número) de la punción; por embrión, estadio, resultado del PGT-A y destino (o los conteos de cada punción). Si no tienen el resultado del PGT-A, al menos si el embrión se biopsió. Es el único dato que separa los abandonos sin embriones viables (G1) de los que tenían embriones y no transfirieron (G2a).
Criopreservación	Recomendable	Paciente y fecha de vitrificación; si está, fecha y tipo de salida. Si solo tienen el inventario actual, sirve igual para los abandonos: después del último procedimiento no hubo movimientos.
Resultados de embarazo	Solo si hace falta	Solo si el resultado no está en Transferencias: paciente, resultado y fecha (o número de transferencia).
Precio de una punción y de una transferencia	Opcional	El honorario de la clínica, sin medicación. Se usa en la calculadora de ingresos del informe; si no lo mandan, la calculadora sale con los campos vacíos para que lo completen ustedes.

Lo mínimo para que el número sea confiable

- El mismo **número de paciente** en todos los reportes y en todas las sedes; si cada sede numera distinto, la tabla de equivalencias. Si cambiaron de sistema o de numeración en el período, cuándo.
- El **desenlace** de cada transferencia, no solo la β-hCG.
- El **tipo** de cada punción: propia, donante, preservación de óvulos o cancelada (o exporten solo las propias y avísennos).
- La **edad** a cada punción, en años. Sin edad no hay informe por edad (menos de 35, 35 a 40, más de 40).
- La **sede** en todos los reportes, si hay más de una.
- La **fecha del procedimiento**, no la de carga en el sistema.

Con embriología y criopreservación, el informe separa los abandonos con y sin embriones guardados; sin esos reportes, lo dice como limitación.

La app acepta los reportes tal como salen

- **Un archivo con varios reportes** (un Excel con varias hojas, o un reporte del sistema con toda la actividad).
- **Un reporte en varios archivos** (por sede o de antes y después de un cambio de sistema): se suman.
- **Una fila por ciclo o por paciente:** la app la separa en punciones y transferencias y pide confirmarlo.

- **La historia clínica como número de paciente:** se reemplaza por un código interno al leer el archivo.
- Si el laboratorio usa otro número de paciente, manden también la tabla de equivalencias que relaciona los dos.

Si un dato no lo tienen

Manden el reporte igual, sin esa columna, y avísennos. No lo completen a mano: un dato que falta se informa como tal; uno inventado distorsiona el resultado. Si el dato falta solo en algunas filas, dejen la celda vacía, no pongan 0. Si está en otro sistema (por ejemplo, el del laboratorio), exporten ese reporte también, como salga. Si un reporte no se puede exportar, avísennos y vemos juntos cómo sacarlo: no hace falta copiarlo a mano en un Excel.

Privacidad: los datos no salen de la computadora

- Todo se calcula en esta computadora: nada sale a internet.
- Nombres, documentos, mails y teléfonos se descartan al leer el archivo; si la historia clínica es la única clave, se reemplaza por un código interno.
- El Excel que sale trae solo conteos y porcentajes, sin fechas ni códigos de paciente; ninguna celda muestra cantidades entre 1 y 10.

Cómo se entrega

Abren la app de LUUMA en la computadora de la clínica, sueltan los reportes, revisan lo que la app pregunta y nos mandan el Excel para LUUMA que genera (solo conteos y porcentajes). La clínica se queda con su informe.

Glosario

Abandono por ciclo. El ciclo no terminó en un bebé y pasaron 12 meses sin ninguna punción, transferencia ni ovodonación en la clínica después de su último procedimiento. Las consultas y los estudios no cuentan como procedimiento. Es la medida principal del informe.

Tipos de abandono. G1: la punción no dejó embriones viables (sin ovocitos, sin blastocistos o todos aneuploides). G2a: quedaron embriones y no hubo transferencia en el ciclo. G2b: después de transferencias sin éxito, quedan embriones. G3: después de transferencias sin éxito, no quedan.

Punción. Aspiración folicular para obtener óvulos propios de la paciente. Cada punción abre un ciclo de tratamiento.

Tipo de punción. Propia: óvulos de la paciente para su tratamiento (la única que abre un ciclo). Donante: punción de una donante del programa de ovodonación. Preservación: óvulos vitrificados para usar más adelante. Cancelada: no hubo aspiración.

Ciclo. Una punción con todo lo que le sigue: las transferencias de los embriones de esa punción, hasta el éxito, una nueva punción u ovodonación, o el abandono.

Transferencia. Colocación de uno o más embriones en el útero, en fresco o con embriones criopreservados.

Embriología por punción. El reporte del laboratorio de cada punción: ovocitos, MII, embriones, blastocistos y, por embrión, resultado del PGT-A y destino. Sirve con una fila por punción o una por embrión.

MII. Ovocito maduro (en metafase II): el único que se puede fecundar.

Blastocisto. Embrión de 5 a 7 días de desarrollo. Es el estadio en el que se biopsia para PGT-A y en el que se transfiere o vitrifica la mayoría de los embriones.

PGT-A. Test genético preimplantatorio de aneuploidías: se biopsia el blastocisto para saber si tiene la cantidad normal de cromosomas.

Euploide, aneuploide, mosaico. Resultados del PGT-A. Euploide: cantidad normal de cromosomas. Aneuploide: cantidad anormal; no se transfiere. Mosaico: mezcla de células normales y anormales; por ahora se cuenta como viable. Sin resultado: la biopsia no dio diagnóstico; se cuenta como sin testear.

Embrión viable. Blastocisto que no es aneuploide (euploide o sin testear). La punción no dejó ninguno si no hubo ovocitos, ni blastocistos, o si todos fueron aneuploides. La app lo calcula desde el reporte de embriología.

Criopreservación. Embriones vitrificados (congelados) en el banco de la clínica. El reporte dice cuándo entró y cuándo salió cada embrión (descongelado, descartado o trasladado); de ahí la app cuenta cuántos quedan después de cada transferencia.

Embriones que quedan. Embriones criopreservados de la paciente después de una transferencia: los congelados hasta ese día que no se descongelaron, descartaron ni trasladaron. Los descongelados para esa transferencia cuentan como usados. Separa los abandonos con y sin embriones guardados.

Ovodonación. Tratamiento con óvulos o embriones de donante. Para esta medición, pasar a ovodonación cuenta como seguir en tratamiento.

Resultado del embarazo. Cómo terminó: negativo (incluye bioquímico y ectópico), pérdida, nacido vivo, en curso a la fecha de corte o sin dato. Una β-hCG positiva sin desenlace cuenta como sin dato.

Fecha del procedimiento. El día en que se hizo la punción o la transferencia, no el día en que se cargó en el sistema.

Fecha de corte. Último día hasta el que el registro está completo. Sirve para saber qué ciclos ya tuvieron 12 meses de seguimiento. No es la fecha del último contacto con cada paciente.

Ciclos previos. Tratamientos de reproducción asistida que la paciente hizo antes de su primera punción del período, en esta u otra clínica. Es opcional.

Número de paciente o historia clínica. El identificador que use la clínica, el mismo en todos los reportes (también en los del laboratorio y el banco). Si el laboratorio usa otro número, sirve una tabla de equivalencias que relacione los dos. La historia clínica se reemplaza por un código interno al leer el archivo y no sale de la computadora.

Sede. Cada clínica o centro de la organización donde se hizo el procedimiento. Va en todos los reportes si hay más de una.

Celdas menores a 11. Para proteger la privacidad, ninguna fila ni celda del Excel muestra cantidades entre 1 y 10: se dejan vacías para que nadie sea identificable.